

# 간수치 상승·지방간 결과 안내

간수치(AST/ALT/SGT) 상승은 흔하지만 원인은 다양합니다. 지방간은 최근 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로도 불리며, 간 자체보다 심혈관질환·간 외 암 위험이 더 문제가 되는 경우가 많습니다. 음주, 약·영양제, 바이러스간염, 근육 손상 등도 함께 확인하고 위험도에 따라 재검과 추가 검사를 정합니다.



## 검사 결과에서 보는 핵심

|                                         |                                          |                                       |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>ALT</b><br><b>간세포</b><br>지방간에서 흔히 상승 | <b>AST</b><br><b>간·근육</b><br>운동 후도 상승 가능 | <b>GGT</b><br><b>담도·음주</b><br>술·약물 영향 | 감량 목표<br><b>5~10</b><br>% 체중 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|

## 흔한 원인과 확인할 검사

### 흔한 원인

**지방간** — 복부비만·당뇨·고중성지방과 동반  
**음주** — GGT 상승, AST가 ALT보다 높을 수 있음  
**약·영양제** — 진통제, 한약, 보충제 포함  
**운동·근육 손상** — AST/CK 동반 상승 가능

### 추가 확인

**간염 검사** — B형·C형 간염 여부  
**복부초음파** — 지방간·담석·간 종괴 확인  
**대사 위험 평가** — 혈당, 지질, 혈압, 허리둘레  
**섬유화 평가** — FIB-4, 필요 시 탄성도 검사  
**약물(우루사 등)** — 간수치는 내려도 지방간 자체는 그대로일 수 있음

## 생활 관리의 우선순위

### 먼저 줄일 것

**술** — 지방간엔 적정 음주량이 없음, 재검 전 2~4주 금주 권장  
**당 음료·과자** — 과당은 지방간 악화와 연관  
**제로 음료·과일주스** — 당 음료와 함께 금지  
**야식·폭식** — 체중보다 복부지방 감소가 중요  
**불필요한 보충제** — 성분 불명 제품은 중단 상담

### 늘릴 것

**주 150분 유산소** — 빠르게 걷기부터 시작  
**주 2회 근력운동** — 인슐린 저항성 개선  
**단백질·채소 중심 식사** — 흰쌀·면·빵 양 줄이기  
**3개월 재평가** — 간수치·체중·허리둘레 비교

### 빨리 진료가 필요한 신호

항달, 콜라색 소변, 심한 우상복부 통증, 발열, 명·코피 증가, 복부 팽만, 원인 모를 체중 감소가 있으면 단순 지방간으로 넘기지 말고 빨리 진료를 보세요. 간수치가 정상이어도 지방간·섬유화가 있을 수 있어 위험요인에 따라 추적이 필요합니다.

